

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DE SOLEDAD DE UCLA REVISADA (UCLA-R)

Eje II: Procesos Psicológicos • Evaluación de la Soledad Subjetiva y Desconexión Vincular Percibida

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala de Soledad de UCLA - Versión 3 Revisada (UCLA-R).
Nombre Original (Inglés)	<i>UCLA Loneliness Scale (Version 3)</i>
Autor Original	Dr. Daniel W. Russell (1996), Iowa State University.
Adaptaciones Españolas	Expósito y Moya (1999); Velarde-Mayol et al. (2016); Sanz et al. (2007).
Eje Clínico y Clasificación	Eje II: Procesos Psicológicos. Modelo Cognitivo de Discrepancia Relacional (Peplau & Perlman).
Tipo de Instrumento	Autoinforme escalar de 20 reactivos con escala Likert de 4 opciones (1 a 4).
Población y Rango	Adolescentes, adultos y personas mayores (≥ 14 años). Ámbito comunitario y clínico.
Tiempo de Administración	3 a 5 minutos en autoadministración; 6 minutos asistido.
Régimen de Licencia	Instrumento psicométrico de acceso abierto para fines clínicos y de investigación académica.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y NEUROBIOLOGÍA DE LA SOLEDAD

La escala UCLA-R es el estándar psicométrico internacional para la cuantificación de la **soledad subjetiva o percibida**. De acuerdo con la teoría cognitiva de Peplau y Perlman, la soledad no se define por el aislamiento físico objetivo (el número de personas presentes), sino por la discrepancia aversiva y dolorosa entre los vínculos interpersonales que una persona anhela tener y las relaciones que siente que efectivamente mantiene.

Las investigaciones neurocientíficas de John Cacioppo han puesto de manifiesto que la soledad crónica actúa como un potente estresor biológico que sitúa al sistema nervioso en estado de alerta defensiva permanente. Induce hiperreactividad del eje simpático-médulo-suprarrenal (elevando el cortisol matutino y la presión arterial), altera la arquitectura del descanso nocturno e incrementa la expresión genética proinflamatoria. En salud mental, la soledad subjetiva predice de manera independiente la aparición de episodios depresivos mayores, deterioro cognitivo acelerado e ideación suicida.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Dimensión del Vínculo	Ítems	Sentido	Fenomenología y Operacionalización Evaluada
1. Conexión y Pertenencia	1, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 19, 20	Inversos (9)	Sentimiento de sintonía con otros, disponibilidad de confidentes, cercanía afectiva y presencia de personas a quienes recurrir.
2. Aislamiento y Vacío	2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18	Directos (11)	Percepción de exclusión, falta de compañía, vivencia de incomunicación, relaciones superficiales e invisibilidad social.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Excepcional precisión: alfa de Cronbach de 0.89 a 0.94 en validaciones españolas (Velarde-Mayol et al., 2016; Expósito & Moya, 1999). Coeficiente test-retest $r = 0.73$ al año.
Estructura Factorial	Aunque fue diseñada como unidimensional, los AFC demuestran que captura tanto un factor general de soledad como tres facetas correlacionadas: Soledad Íntima, Soledad Relacional y Soledad Colectiva.
Validez Concurrente	Elevada correlación con depresión (BDI-II, $r = 0.62$), ansiedad social ($r = 0.53$), afecto negativo e insomnio; e inversas con autoestima ($r = -0.56$) y apoyo social percibido (MSPSS, $r = -0.68$).
Sensibilidad al Cambio	Sensible a intervenciones grupales de apoyo comunitario, talleres de habilidades sociales y programas de prescripción social en atención primaria.
Invarianza en Envejecimiento	Validada rigurosamente en adultos mayores y residencias geriátricas, manteniendo plena validez de constructo transgeneracional.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

Cada uno de los 20 reactivos se responde según la frecuencia percibida: **1** = «Nunca», **2** = «Raras veces», **3** = «A veces», **4** = «A menudo».

- **Paso 1 (Inversión Obligatoria de 9 Reactivos Positivos):** Los ítems **1, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 19 y 20** se puntúan de forma invertida: $1 \rightarrow 4$, $2 \rightarrow 3$, $3 \rightarrow 2$, $4 \rightarrow 1$.
- **Paso 2 (Puntuación Total UCLA-R):** Suma directa de los 11 ítems no invertidos más los 9 ítems ya invertidos.
- **Rango Teórico: 20 a 80 puntos.** A mayor puntuación, mayor severidad de la soledad y desconexión social experimentada.

6. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y PUNTOS DE CORTE

Estratificación	Puntuación	Estado Vincular	Enfoque de Intervención Asistencial
Baja Soledad	20 a 34	Conexión interpersonal adaptativa	Red social percibida como continente y nutritiva. Factor de resiliencia afectiva general.
Moderada	35 a 49	Insatisfacción vincular intermitente	Sensación ocasional de incompreensión o lejanía. Explorar expectativas relacionales y habilidades sociales.
Alta	50 a 64	Soledad clínica significativa (corte ≥ 50)	Aislamiento afectivo severo; disparador de depresión y ansiedad. Indicación de psicoterapia e inclusión comunitaria.
Severa / Extrema	65 a 80	Desconexión vincular crítica	Vivencia de abandono absoluto, desamparo y marginación. Alto riesgo psicopatológico y de deterioro vital.

ALERTA CLÍNICA: PUNTUACIÓN UCLA-R ≥ 50 :

En pacientes médicos o psiquiátricos, un puntaje ≥ 50 multiplica por 3 el riesgo de abandono del tratamiento y empeora el pronóstico cardiovascular y metabólico. En ancianos, acelera la conversión de quejas subjetivas de memoria a deterioro cognitivo leve.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA EN SOLEDAD Y AISLAMIENTO

GUÍA DE INTERVENCIÓN EN SOLEDAD CRÓNICA:

- **Paso 1: Diagnóstico de la Causa Nuclear:** Diferenciar si la soledad se debe a déficit de oportunidades objetivas (vínculos ausentes) o a sesgo cognitivo de hipervigilancia a la amenaza social (la persona rechaza a otros anticipando que será rechazada).
- **Paso 2: Reestructuración de la Amenaza Social:** La soledad crónica distorsiona la cognición social, haciendo que las personas neutras parezcan hostiles. Desmantelar la interpretación paranoide del desinterés ajeno.
- **Paso 3: Prescripción Social y Vínculos de Calidad:** Fomentar actividades compartidas significativas basadas en intereses comunes (no forzar contactos superficiales masivos). Monitorizar con UCLA-R; un descenso de ≥ 8 puntos denota reconexión efectiva.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN ANCIANO CON SOLEDAD NO DESEADA

Paciente: Varón de 73 años, viudo desde hace 14 meses, acude a consulta de atención primaria por insomnio pertinaz, hiporexia y quejas somáticas vagas recurrentes. Vive solo y sus hijos residen en otra ciudad.

Evaluación UCLA-R Inicial: 64 puntos (Nivel Severo; percentil 94).

• **Ítems Invertidos Críticos:** Ítem 1 = 1 (recodificado 4: no siente sintonía con nadie); Ítem 10 = 1 (recodificado 4: no tiene a nadie cercano); Ítem 19 = 1 (recodificado 4: nadie con quien hablar de cosas íntimas).

• **Ítems Directos:** Ítem 3 = 4 («Nadie a quien acudir en caso de necesidad»); Ítem 14 = 4 («Nadie me conoce realmente»).

Formulación Clínica: Soledad no deseada complicada con duelo no resuelto. El aislamiento activa el sesgo de que «es una carga para los demás», lo que le impedía llamar a sus hijos o relacionarse con vecinos.

Intervención y Evolución: Programa combinado de Prescripción Social (incorporación a club de lectura municipal y taller de horticultura comunitaria) más 6 sesiones de terapia cognitivo-conductual sobre distorsiones de rechazo. A los 4 meses, la puntuación UCLA-R descendió a **36 puntos**, normalizándose el sueño y cesando las visitas hiperfrecuentadoras al centro de salud.

9. ALERTAS CLÍNICAS Y GESTIÓN DE RIESGO

ALERTA CRÍTICA: SOLEDAD Y RIESGO AUTOLÍTICO

En la Teoría Interpersonal del Suicidio de Joiner, la soledad severa (UCLA-R ≥ 60) conforma el constructo de «Pertenencia Frustrada» (Thwarted Belongingness). Asociada a la percepción de ser una carga, constituye la vía directa a la ideación suicida activa.

CAUTELA EN LA CORRECCIÓN DE ÍTEMS INVERTIDOS

Es obligatorio verificar que los 9 reactivos redactados positivamente hayan sido invertidos antes de sumar el puntaje total. Omitir la inversión distorsiona gravemente el perfil psicométrico global.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Russell, D. W. (1996). UCLA Loneliness Scale (Version 3): Reliability, validity, and factor structure. *Journal of Personality Assessment*, 66(1), 20–40.
2. Velarde-Mayol, C., Fragua-Gil, S., & García-de-Cecilia, J. M. (2016). Validación de la Escala de Soledad de UCLA y perfil sociodemográfico en la población anciana de Madrid. *Semergen*, 42(3), 177–183.
3. Cacioppo, J. T., & Cacioppo, S. (2018). The growing problem of loneliness. *The Lancet*, 391(10119), 426.
4. Expósito, F., & Moya, M. (1999). Soledad y apoyo social en estudiantes universitarios: validación de la Escala UCLA. *Revista de Psicología Social*, 14(2-3), 319–339.